

CLINICAL FRAILITY SCALE – norsk

Klinisk skrøpeligheitsskala – vurder ut fra pasientens funksjonsnivå ca. 2 uker før akutt sykdom

1 Veldig sprekk	Personer som er robuste, aktive, energiske og motiverte. De trener gjerne regelmessig, og er blant de sprekeste i sin aldersgruppe.
2 Sprekk	Personer som ikke har aktive sykdomssymptomer , men er mindre spreke enn kategori 1. Kan ofte trene eller være veldig aktive av og til, f.eks. sesongbasert.
3 Klarer seg bra	Personer med velkontrollerte medisinske problemer , selv om de kan ha symptomer av og til. Er ikke regelmessig aktive utover vanlig gange.
4 Lever med svært mild skrøpeligheit	Tidligere «sårbar». Markerer en overgang fra å være helt selvhjulpne. Ikke avhengig av daglig hjelp, men symptomer begrenser aktivitet . Klager ofte over å være «langsomme» og/eller slitne/trøtte i løpet av dagen.
5 Lever med mild skrøpeligheit	Mer tydelig langsomme, og trenger hjelp til komplekse aktiviteter i dagliglivet (økonomi, transport, tungt husarbeid). Mild skrøpeligheit vil i økende grad føre til problemer med å handle, gå ut alene, lage mat, håndtere medisiner og lett husarbeid.
6 Lever med moderat skrøpeligheit	Må ha hjelp til alle aktiviteter utendørs og med å stelle hjemmet. Innendørs problemer med trapper, trenger hjelp til bading/dusj og litt hjelp til påkledning (veiledning, tilsyn).
7 Lever med alvorlig skrøpeligheit	Helt avhengige av hjelp til personlig stell uansett årsak (fysisk eller kognitiv). Fremstår likevel som stabile og uten høy risiko for å dø (innen ~6 måneder).
8 Lever med svært alvorlig skrøpeligheit	Helt avhengige av hjelp til personlig stell og nærmer seg livets slutt. Kommer vanligvis ikke seg igjen selv etter mild sykdom.
9 Terminalt syk	Nærmer seg livets slutt. Forventet levetid <6 måneder uten at de lever med alvorlig skrøpeligheit. (Mange terminalt syke kan være fysisk aktive til svært nær døden.)

Skåring av skrøpeligheit hos personer med demens

Graden av skrøpeligheit tilsvarer vanligvis graden av demens (CFS 5, 6, 7 eller 8). Vanlige symptomer ved **mild demens** inkluderer å glemme detaljer rundt en nylig hendelse, selv om man husker selve hendelsen, å gjenta de samme spørsmålene/historiene og sosial tilbaketrekking.

Ved **moderat demens** er korttidsminnet svært svekket, selv om de virker å huske hendelser fra tidligere i livet. De kan ivareta egenomsorg under veiledning. Ved **alvorlig demens** må de ha hjelp til all egenomsorg. Ved **svært alvorlig demens** er de ofte sengeliggende. Mange har mistet alt språk.

Clinical Frailty Scale © 2005–2020 Rockwood K et al. Version 2.0 (NO). All rights reserved.
www.geriatricmedicineresearch.ca

Rockwood K et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489–495.

Oversatt med tillatelse av Rostoft S, Engstad TT, Sjøbø B, Flaatten H.